

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

CUERPO EXTRAÑOS INTRANASALES

Introducción

Afección muy frecuente sobre todo en niños de entre 1 y 4 años. Naturaleza variable: piedras, juguetes, organismos vegetales...etc. Importante diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones. Clínica frecuente de rinorrea mucopurulenta o sanguinolenta unilateral. Debemos tener especial cuidado con las pilas ya que tienen riesgo de producir en pocas horas daño en mucosa por decúbito, lesiones cáusticas y quemaduras químicas (electrolisis y producción de hidróxido de potasio).

Se suelen encontrar generalmente en la zona anterior (meato inferior, entre tabique y cornete medio), pero se debe tener cuidado con los que penetran hasta vía posterior ya que existe riesgo de aspiración si el cuerpo extraño cae por la nasofaringe.

Diagnóstico:

- Clínica de rinorrea purulenta unilateral, con posible edema y eritema de dorso nasal. Halitosis, rinolalia, cefalea, insuficiencia nasal respiratoria.
- Se realizará **rinoscopia anterior**, puede ser de ayuda aspirar secreciones con cuidado de no empujar el cuerpo extraño o también la colocación de mechas con anestesia tópica y vasoconstrictor para una mejor exploración.
- **Radiografía simple de senos paranasales y cavum** si sospecha de cuerpo extraño radiopaco o
- **TAC y fibrolaringoscopia** si fuese necesario.
- Es posible que pasen desapercibidos durante mucho tiempo según la naturaleza de su origen. Pueden originar úlceras y posterior necrosis osteocartilaginosa cuando se trata de componente reactivos (pilas)
- Son infrecuentes las complicaciones graves como la celulitis facial.

Tratamiento

- En pacientes pediátricos, inmovilizar al paciente y realizar extracción mediante técnica adecuada,.
- Utilizar un gancho romo y aspiración, realizando la extracción de dentro a fuera o mediante succión. Nunca empujar el cuerpo extraño hacia posterior. Riesgo de aspiración.
- Tras la extracción realizar lavados nasales en domicilio y seguimiento si precisa.

No realizar intentos repetidos; derivar a ORL para valoración y extracción con cirugía endoscópica y anestesia general si fuese preciso.

Nota

- Importante realizar extracción del cuerpo extraño de forma temprana y con instrumental adecuado. El personal debe conocer la técnica, ya que corremos el riesgo de introducirlo más profundamente y producir aspiración del cuerpo extraño.

Bibliografía

- Chacón Martínez J, Morales Puebla J.M, Padilla Parrado M. Capítulo 50. Epistaxis y cuerpos extraños nasales. Libro virtual de formación de ORL.

- Gicquel P, Fontanel JP. Cuerpos extraños de las fosas nasales. Rinolitiasis. En: Encycl Méd Chir Oto-rhino-laryngologie. Paris: Elsevier; 20-390-A-10, 1995: 1-5
- Artigas-Sapiain C, Sarriá-Echegaray P, Tomás-Barberán M. Manejo de cuerpos extraños nasales y óticos en niños. Semergen. 2010;36(5):278–282.
- Eisele D, McQuone S. Emergencies of the Head and Neck. Editorial Mosby; 2000.
- Cummings otolaryngology–head & neck surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.